

EDUCACIÓN EN DIABETES

una urgente necesidad en **Latinoamérica**

Hacia un Modelo Regional de Educación Terapéutica en Diabetes

Mgs. Ana Fernanda Sánchez E.

Directora, Casa de la Diabetes — Fundación Los Fresnos

Vicepresidenta de IDF, periodo 2022-2025

Representante, Grupo de Investigación en Educación Terapéutica de ALAD – Ecuador

Actual Delegada de ALAD Ecuador

Panorama regional de la diabetes en Latinoamérica

Datos que evidencian la urgente necesidad de fortalecer la educación terapéutica



10,6%

Prevalencia de diabetes
en población adulta
latinoamericana



32 M+

Personas afectadas
en la región



+50%

Incremento proyectado
de casos hacia el año 2045



USD 97 mil M

Gasto anual en salud
destinado
al manejo de la diabetes



Más del 60% de las personas con diabetes en la región mantienen HbA1c > 7%. La falta de educación estructurada contribuye directamente al descontrol metabólico y a la progresión de complicaciones.

El costo de no invertir en educación: el caso de Ecuador

Micro-costeo de la atención integral de la diabetes tipo 2 (Arias-Pacheco et al., 2025)

SIN EDUCACIÓN ESTRUCTURADA

USD 11.704,38

costo promedio anual por paciente, incluyendo complicaciones

USD 11.565,81 millones

costo agregado nacional estimado



−97%

CON EDUCACIÓN TERAPÉUTICA ESTRUCTURADA

USD 295,67 millones

gasto nacional proyectado al implementar estrategias preventivas y de educación estructurada

La prevención primaria y la educación estructurada son la vía más costo-efectiva para mitigar la carga de la DM2.

Un problema estructural: educación fragmentada y no estandarizada



Heterogeneidad y vacíos

Actualmente existe heterogeneidad y vacíos: la educación terapéutica se ofrece de forma dispersa, no regulada y sin estándares mínimos.



Menor impacto clínico

La variabilidad actual disminuye el impacto: sin estandarización, no se garantiza calidad ni continuidad entre países, instituciones o niveles de atención.



La evidencia sí funciona

La evidencia demuestra que los programas estructurados sí funcionan: reducción de HbA1c 0,5–0,8%, mayor adherencia y mejor capacidad de autocuidado.

En muchos contextos latinoamericanos, la educación terapéutica continúa siendo fragmentada, no estandarizada y dependiente de iniciativas individuales, sin integración formal en los modelos de atención.

La educación en diabetes: una intervención terapéutica esencial, no opcional



Reconocida por OMS, OPS y ADA como intervención terapéutica obligatoria del cuidado de la diabetes.



Reduce complicaciones micro y macrovasculares, hospitalizaciones y mortalidad.



Empodera a la persona: incrementa autoeficacia, alfabetización en salud y adherencia al tratamiento.



Favorece la toma de decisiones compartida dentro del Modelo de Cuidados Crónicos.

-0,76%

Norris et al.

Reducción media de HbA1c en programas estructurados de educación terapéutica.

-0,57%

Chrvala et al.

Reducción de HbA1c y mejoras significativas en presión arterial y colesterol total.

↓ costos

Powers et al.

La educación dirigida por equipos multidisciplinarios reduce hospitalizaciones y costos sanitarios.

La educación es tan importante como los medicamentos: sin ella, no hay control sostenido.

¿Por qué un modelo regional estandarizado?



Garantiza equidad

Todas las personas, sin importar su país o servicio de salud, reciben el mismo nivel mínimo de calidad de educación en diabetes.



Permite medir y comparar resultados

Un sistema educativo estándar facilita indicadores, auditoría, investigación y mejora continua.



Facilita el Modelo de Cuidados Crónicos

La estandarización permite que el apoyo al autocuidado sea replicable, evaluable y sostenible.



Profesionaliza al educador

Define competencias, currículos, horas mínimas y procesos de certificación.



Favorece la interoperabilidad

Registros educativos estandarizados permiten integrar datos clínicos y educativos regionalmente.

Estos beneficios convierten la estandarización en la base para escalar la educación en diabetes a nivel regional.

Modelo de Cuidados Crónicos (MCC)

Chronic Care Model — Wagner et al. (2001), adaptado al contexto regional por la OPS



- La atención actual es fragmentada, episódica y centrada en la enfermedad.
- El MCC propone atención proactiva, continua y centrada en la persona.
- La educación estructurada es la intervención más costo-efectiva del modelo.

Los 5 pilares del Modelo Regional de Educación Terapéutica en Diabetes

Operacionalización progresiva del Modelo de Cuidados Crónicos aplicado a la educación en diabetes



Marco técnico y operativo adaptado a la realidad organizativa, cultural y sanitaria de Latinoamérica, con fundamento en evidencia GRADE.

1 Pilar 1 · Apoyo al autocuidado

El educador en diabetes debe estructurar, implementar y evaluar programas de autocuidado que aborden los 7 componentes esenciales de la Guía IDF-SACA.



**Alimentación
saludable**



**Actividad
física regular**



**Automonitoreo
glucémico**



**Adherencia
terapéutica**



**Resolución
de problemas**



**Afrontamiento
emocional**



**Reducción
de riesgos**

Perfil del educador (Guía IDF-SACA)

Debe demostrar competencia pedagógica y clínica en los 7 contenidos, con adaptación cultural, familiar y comunitaria. Los programas con ≥ 11 –12 horas de contacto estructurado muestran mejoras clínicamente significativas en HbA1c, automanejo e indicadores de autocuidado.

El apoyo al autocuidado no es competencia exclusiva del educador: involucra a familiares, pares expertos, equipo de salud y redes comunitarias.

2

Apoyo a la toma de decisiones



Fortalece la capacidad decisional del equipo interdisciplinario con herramientas basadas en evidencia (GRADE, Evidence to Decision).



Programa de Mentoría Clínica Regional: internistas, endocrinólogos, educadores certificados, enfermeras y nutricionistas — 6 meses, práctica supervisada.



Indicadores duros de seguimiento: reducción de HbA1c $\geq$ 0,5%, menor tasa de hospitalizaciones, amputaciones y progresión de nefropatía.

3

Sistema de información clínica y educativa



Registro estandarizado y trazable de todo contacto educativo o asistencial, bajo principios FAIR (localizable, accesible, interoperable, reusable).



Plataformas de bajo costo y alta escalabilidad: REDCap, DHIS2 y OpenMRS, con niveles de acceso según rol (educador, médico, auditor, gestor).



Los programas basados en registros electrónicos y retroalimentación continua logran reducir la HbA1c entre 0,5% y 0,8%.

Los pilares 2 y 3 convierten la evidencia en decisiones medibles y trazables en tiempo real.

4

Reorganización del servicio



Creación de Espacios de Educación en Diabetes, dentro de hospitales y centros de atención primaria, con roles y protocolos definidos.



Atención grupal ("Group Care"): 8–12 personas con diabetes, sesiones de 90 minutos cada 1–2 meses — costo-efectiva, mejora HbA1c y adherencia.



Rutas asistenciales y educativas longitudinales que acompañan diagnóstico, tratamiento, seguimiento y prevención de complicaciones.

5

Integración con la comunidad



Plan de actividades que vincula los servicios de salud con organizaciones comunitarias: escuelas, iglesias e instituciones culturales.



Creación de unidades de autocuidado en diabetes y otras condiciones crónicas, con fortalecimiento de la comunidad del cuidado.



Especial atención a transiciones vitales: de la niñez a la adolescencia, y de la adolescencia a la adultez joven.

Los pilares 4 y 5 llevan la educación en diabetes del consultorio a la comunidad, con continuidad y pertinencia cultural.

Resultados esperados y recursos disponibles

0,5–0,8%

Reducción esperada
de HbA1c

–29%

Disminución de
hospitalizaciones



Mayor adherencia
terapéutica

1

Estándar regional
de educación en
diabetes

Guía de Práctica Clínica de Educación en Diabetes



Resultado del trabajo articulado de la **Federación Internacional de Diabetes, Región SACA**, y de profesionales especializados en educación en diabetes de los países de América Latina y el mundo.

Inglés

Español

Portugués

Encuéntrala aquí



Escanea el código QR
o visita www.casadeladiabetes.org.ec

PRÓXIMAMENTE · NOVIEMBRE 2026

El Modelo Regional de Educación Terapéutica en Diabetes está en camino

Un nuevo estándar regional para la educación en diabetes en Latinoamérica, construido con expertos de toda la región.



Marco de competencias y currículo mínimo para educadores en diabetes.



5 pilares operativos: autocuidado, decisiones, información, servicios y comunidad.



Checklists y herramientas de evaluación listas para implementar en cada servicio.



Indicadores regionales para medir calidad, cobertura y resultados clínicos.



Modelo Regional de Educación Terapéutica en Diabetes



Un vistazo al Modelo Regional

Un adelanto de algunas de las secciones que incluirá el documento completo.

Dominio	Indicador	Tipo
Control Metabólico	HbA1c<7%	Resultado
Autocuidado	≥ 75% adherencia terapéutica	Proceso
Educación	Paciente con plan educativo completo	Cobertura
Alfabetización	Nivel ≥3 en escala eHEALS	Resultado
Gestión	% registros completos en REDCap	Calidad dato

Indicadores estratégicos del MCC

2. Actividad física - Competencia del Educador

Ítem	Si	No	Observaciones
Explica beneficios del ejercicio sobre glucemia y peso.	☐	☐	
Diferencia actividad aeróbica, fuerza y movilidad (y cuando aplicarlas).	☐	☐	
Enseña cómo ajustar medicación o alimentación antes/durante ejercicio.	☐	☐	
Realiza educación basada en alimentación familiar/comunitaria, no solo alimentación.	☐	☐	
Evalúa comprensión de la persona con diabetes (ejemplo práctico, menú o menú).	☐	☐	

3. Automonitoreo - Competencia del Educador.

Ítem	Si	No	Observaciones
Enseña uso correcto del glucómetro (técnica, técnica, calibración).	☐	☐	
Explica cuándo y cuántas veces monitorear según tratamiento.	☐	☐	
Asiste a la persona con diabetes a interpretar resultados y actuar (pico hiperglucemia, hipo...).	☐	☐	
Mantiene registro en cuaderno, app o sistema electrónico.	☐	☐	
Evalúa errores en técnica y corrige oportunamente.	☐	☐	

4. Adherencia terapéutica - Competencia del Educador

Ítem	Si	No	Observaciones
Evalúa con claridad nombre, dosis y mecanismo de medicamentos.	☐	☐	
Enseña técnicas de aplicación de insulina o uso de dispositivos (pluma, bombas).	☐	☐	
Mantiene registros para evaluar barreras de adherencia.	☐	☐	
Mantiene registro en cuaderno, app o sistema electrónico.	☐	☐	
Evalúa errores en técnica y corrige oportunamente.	☐	☐	

5. Resolución de problemas cotidianos - Competencia del Educador

Ítem	Si	No	Observaciones
Enseña cómo actuar ante hipoglucemia o hiperglucemia inesperada.	☐	☐	
Explica manejo de "sick day rules" (días de enfermedad).	☐	☐	
Enseña qué hacer si se olvidó dosis de insulina o alimentación.	☐	☐	
Trabaja con la persona con diabetes situaciones reales (viajes, no tener comida, fiestas).	☐	☐	
Conoce los conceptos y aplicabilidad práctica relacionados con la enfermedad.	☐	☐	
Conoce los conceptos y aplicabilidad práctica relacionados con la enfermedad.	☐	☐	
Mantiene uso del plan educativo.	☐	☐	

Anexo 1 • Checklist de competencias del educador

GRACIAS

anaferny017@gmail.com

www.casadeladiabetes.org.ec